

УДК: 616.34-006.6:615.277

О.В.Жаркова¹, В.В.Карасева², В.А.Хайленко², Е.Б.Миронова³, П.С.Феоктистова⁴, К.В.Вялова¹,
С.А.Коломиец¹

¹ГБУЗ КО Областной клинический онкологический диспансер, г. Кемерово

²Российский национальный исследовательский МУ им. Н.И. Пирогова, Москва

³ФГБУЗ Клиническая больница №81 г. Северск,

⁴БУ ХМАО-Югры Нижневартовский онкологический диспансер

Анализ лекарственной терапии диссеминированного колоректального рака в амбулаторной клинической практике

Аннотация. Изучена эффективность двух программ химиотерапии в лечении 46 больных диссеминированным колоректальным раком. Показано, что программа химиотерапии оксалиплатин + капецитабин, созданная авторами, в комбинации с бевацизумабом позволила добиться лучших непосредственных результатов по сравнению с программами оксалиплатин + 5-фторурацил + лейковорин в комбинации с бевацизумабом. Общая эффективность программы OXA/5-FU/LV/BEV составила $40,91 \pm 8,6\%$, из них $4,54 \pm 5,1\%$ полных регрессий. Общий эффект терапии в группе OXA/CAP/BEV составил $45,83 \pm 8,6\%$, из них полной регрессии удалось добиться у четырех пациентов, что составило $16,66 \pm 5,6\%$. Медиана времени до прогрессирования в первой группе больных составила 8,3 месяца, во второй – 9,8 месяцев. Амбулаторное применение бевацизумаба в комбинации с различными режимами химиотерапии у больных диссеминированным раком ободочной кишки сопровождается приемлемой и управляемой токсичностью, что не требует редукции доз.

Ключевые слова: колоректальный рак, химиотерапия.

Актуальность

Проблема колоректального рака на сегодняшний день является актуальной для современной онкологии из-за высокой заболеваемости и значительной смертности в России и других развитых странах мира. Ежегодно в мире регистрируется около 800 тысяч больных колоректальным раком и около 400 тысяч смертей от этого заболевания [1]. В 2010г. в России выявлено более 40 тысяч новых случаев колоректального рака [2, 3]. Так как контингент больных с диссеминированным колоректальным раком складывается из пациентов с впервые выявленной IV стадией заболевания, а также больных I, II, III стадий, у которых рецидивы и отдаленные метастазы возникают в разные сроки после радикального лечения, основным методом лечения указанной группы больных является химиотерапия. Успехи в лекарственном лечении диссеминированного колоректального рака во многом определяются разработкой и внедрением в клиническую практику, как новых противоопухолевых препаратов, так и более рациональных режимов введения цитостатиков [4, 5, 6]. С 2006 года в ГБУЗ КО ОКОД при лечении диссеминированных

форм колоректального рака применяется антиангиогенный препарат бевацизумаб.

Цели исследования

Изучить эффективность и токсичность бевацизумаба в комбинации с двумя программами химиотерапии у больных метастатическими формами колоректального рака.

Методы

Две группы больных получали лечение по следующим программам: первая группа - оксалиплатин 100 мг/м^2 внутривенно в 1 день, лейковорин 20 мг/м^2 + 5-фторурацил 500 мг/м^2 внутривенно с 1 по 5 дни, интервал между курсами 3 недели. Лечение по этой программе получили 22 человека. Вторая группа (24 пациента) получала лечение по программе оксалиплатин 50 мг/м^2 внутривенно в 1,8,15 дни, капецитабин 2000 мг/м^2 внутрь с по 14 дни. Интервал между курсами 2 недели. Все пациенты получали бевацизумаб в дозе 5 мг/кг в 1 и 15 дни курса.

Всем больным до начала лечения и в процессе его выполнялось обследование по следующей программе: клиническое обследование, клинический анализ крови, клинический анализ мочи, биохимический анализ крови, электрокардиограмма, коагулограмма, рентгенография легких, фиброгастроскопия, фиброколоноскопия, УЗИ брюшной полости и/или компьютерная томография брюшной полости.

Каждый больной получил не менее четырех курсов химиотерапии, после чего выполнялась оценка непосредственного эффекта по степени регрессии опухоли под влиянием химиотерапии по критериям RECISTv.1.1. Оценка степени выраженности побочных реакций оценивалась в соответствии с рекомендациями CTC-NCI, v.2.0.

Методы статистической обработки

Для удобства статистической обработки все данные были внесены в базу данных, созданную на основе электронных таблиц EXCEL. Статистическая обработка данных проведена с помощью программного пакета «Statistica 6.0» (StatSoftInc). Достоверность различий между нормально распределенными количественными показателями вычисляли по критерию t Стьюдента. Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Характеристика исследуемых групп

В каждую группу включались больные, у которых впервые установлен рак толстой кишки IV стадии и пациенты, у которых возник рецидив заболевания после предшествующего оперативного лечения по поводу более ранних стадий. Также включены больные, которым выполнены паллиативные оперативные вмешательства на различных отделах толстой кишки. Возраст больных не старше 75 лет. Объективный статус по ECOG не больше 2 баллов. Диагноз рака толстой кишки верифицирован по данным гистологического и цитологического исследования. Те пациенты, которые получали предшествующую химиотерапию, в исследование не включались. Таким образом, пролечено 46 больных диссеминированным раком ободочной кишки в возрасте от 28 до 73 лет, среди них мужчин – 30, женщин – 16. Характеристика больных и опухолевого процесса представлена в таблице 1.

Нарушение общего состояния больных оценено по шкале ECOG. У всех больных диагноз подтвержден гистологически. Характеристика преимущественной локализации метастазов до начала лечения показывает, что отмечалась значительная частота метастатического поражения печени, легких и плевры, реже – местный рецидив, метастазы в забрюшинные лимфатические узлы и яичники.

Результаты

Эффективность лечения оценивалась в соответствии с критериями RECIST v.1.1. у всех 46 больных, получивших не менее 4 курсов лечения. Общий эффект программы OXA/5-FU/LV/BEV по сумме полных и частичных регрессий составил $40,91 \pm 8,6\%$, из них $4,54 \pm 5,1\%$ полных регрессий. Общий эффект терапии в группе OXA/CAP/BEV составил $45,83 \pm 8,6\%$ (11 больных), из них полной регрессии удалось добиться у четырех пациентов, что составило $16,66 \pm 5,6\%$. Медиана времени до прогрессирования в первой группе больных составила 8,3 месяца, во второй – 9,8 месяцев. В группе OXA/CAP/BEV трое из пяти пациентов с изолированными метастазами в печень были прооперированы после 3-х месяцев лечения по указанной программе, возникшие у пациентов послеоперационные осложнения не были связаны с предшествующей терапией бевацизумабом (таблица 2).

Таблица 2 - Эффективность химиотерапии в комбинации с бевацизумабом

Непосредственный эффект	OXA/5-FU/LV/BEV Число больных/%	OXA/CAP/BEV Число больных/%
Полная регрессия	1/4,55	4/16,66 (p<0,05)
Частичная регрессия	8/36,36	7/29,17 (p=0,1)
Стабилизация	9/40,91	10/41,67 (p=0,1)
Прогрессирование	4/18,18	3/12,50 (p=0,1)
Всего больных	22/100	24/100

Следует подчеркнуть высокую значимость симптоматического эффекта для этой тяжелой категории пациентов. В процессе лечения проводилась оценка симптоматического эффекта изучаемых программ химиотерапии, о чем судили по увеличению физической активности (изменение статуса по шкале ECOG), по ослаблению болей (на основании жалоб пациентов), по изменению массы тела. Динамика общего состояния больных представлена в таблице 3.

Таблица 1- Характеристика больных и опухолевого процесса

Показатель	OXA/5-FU/LV/BEV Число больных/%	OXA/CAP/BEV Число больных/%
Пол: мужской женский		
Средний возраст, годы	14/63,64	16/66,67
Объективный статус по ECOG:	8/36,36	8/33,33
0	57,8 лет	53,2 года
1		
2	7/31,82	8/33,33
3	8/36,36	9/37,50
Предшествующее оперативное лечение:	5/22,72	5/20,83
-радикальные операции	2/9,10	2/8,34
-паллиативные операции	7/31,82	
-не выполнялось	7/31,82	5/20,83
Распространенность опухолевого процесса:	8/36,36	4/16,67
-метастазы в печень	9/40,90	15/62,50
-метастазы в легкие/плевру	2/9,10	6/25,00
-метастазы в забрюшинные лимфоузлы	1/4,54	8/33,33
-диссеминация по брюшине	-	4/16,67
-метастазы в яичники	5/22,72	3/12,50
-местный рецидив		1/4,17
		4/16,67
Всего больных	22	24

Таблица 3 - Изменение объективного статуса больных

Объективный статус по ECOG	До лечения Число больных/%	После лечения Число больных/%
0 степень	15/32,62	23/50,00 (p<0,05)
1 степень	17/36,96	15/32,62 (p=0,1)
2 степень	10/21,73	6/13,04 (p=0,1)
3 степень	4/8,69	2/4,34 (p=0,1)
Всего больных	46/100	46/100

После окончания химиотерапии по представленным программам уменьшилось число больных, изначально имевших нарушения общего состояния 2 и 3 степени. И если до начала химиотерапии не имели нарушений общего состояния 15 больных (32,62%), то после ее окончания эта группа увеличилась до 23 пациентов (50,0%).

Таблица 4 - Побочные реакции химиотерапии

Побочные проявления и степень их выраженности	OXA/5-FU/LV/BEV Число больных /%	OXA/CAP/BEV Число больных/%
Гематологические:		
-нейтропения I-II		
-нейтропения III	24/27,27	22/23,91 (p=0,1)
-тромбоцитопения II	6/6,82	3/3,26 (p=0,1)
-анемия II	4/4,54	2/2,17 (p=0,1)
Гастроинтестинальные:	2/2,27	4/4,35 (p=0,1)
-тошнота/рвота II		
-диарея II	23/26,14	26/28,26 (p=0,1)
-стоматит I-II	4/4,54	4/4,35 (p=0,1)
-боль в животе II	6/6,82	4/4,35 (p=0,1)
Неврологические:	2/2,27	2/2,17 (p=0,1)
-парестезии конечностей I-II	21/23,86	26/28,26 (p=0,1)
Кожные:		
-ладонно-подошвенный синдром	3/3,40	16/17,39 (p<0,05)
Всего курсов	88	92

Токсичность терапии

Токсичность программы изучена на основе использования шкалы CTC-NCI, v. 2.0 у всех 46 больных, представлена в таблице 4.

Частоту побочных реакций рассчитывали на общее количество курсов. Токсические проявления при проведении химиотерапии бевацизумабом в комбинации с капецитабином и оксалиплатином, а также в комбинации с 5-фторурацилом и лейковорином были весьма разнообразными, но встречались, в целом, нечасто, были умеренной степени выраженности и связаны, в основном с воздействием цитостатиков. Клинически значимых осложнений, требующих прекращения терапии, зарегистрировано не было.

Заключение

Лекарственная терапия рака толстой кишки в настоящее время сделала значительный шаг вперед, как за счет внедрения в клинику новых противоопухолевых химиотерапевтических агентов, так и препаратов целевой терапии. Результаты, полученные в нашей работе, оказались сопоставимыми с результатами, полученными в исследованиях BRIT и ARIES [7, 8].

Таким образом, амбулаторное применение бевацизумаба в комбинации с различными режимами химиотерапии у больных диссеминированным раком ободочной кишки сопровождается низким риском осложнений и увеличивает время до прогрессирования, что позволяет надеяться на улучшение отдаленных результатов лечения данной категории пациентов.

Список литературы

- 1 WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Worldhealth statistics, 2010.
- 2 Состояние онкологической помощи населению России в 2011 году // Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой / - М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена», 2012. - 240 с.
- 3 Злокачественные новообразования в России в 2010 году (заболеваемость и смертность) // Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой / М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» - 2012. - 260 с.
- 4 Гарин А.М., Базин И.С. Десять наиболее распространенных злокачественных опухолей / Рак желудка, рак толстой кишки, рак поджелудочной железы, первичный рак печени. - М.: КМК, 2006. - 266 с.
- 5 Гарин А.М., Базин И.С. Справочное руководство по лекарственной терапии солидных опухолей. - М.: МГУ, 2007. - 300 с.
- 6 Базин И.С., Гарин А.М. Таргетные антиангиогенные препараты в терапии солидных опухолей // Врач. - 2008. - №1. - С. 52-55.
- 7 Kozloff A., VanCutsem et al. Oncologist 2009 // Ann. Oncol. - 2009.
- 8 Cohn et al. O. - ASCO, 2010.

Тұжырым

О.В.Жаркова¹, В.В.Карасева², В.А.Хайленко³, Е.Б.Миронова³, П.С.Феоктистова⁴, К.В.Вялова¹, С.А.Коломиец¹

¹Кемеровоның облыстық клиникалық онкологиялық диспансері, Кемерово қ.

²Н.И. Пирогов атындағы Ресейлік ұлттық зерттеу медициналық университеті, Мәскеу.

3 Клиническая аурухана №81. Северск қ.

⁴Югры Нижневартовтың онкологиялық диспансер.

Амбулаториялық клиникалық тәжірибеде диссеминирленген колоректальды қатерлі ісіктің дәріліктерінің анализі

Диссеминирленген колоректальды қатерлі ісігі бар 46 науқасқа жүргізілген 2 бағдарламалық химиотерапияның эффективтілігі зерттелінді. Оксалиплатин, капецитабин + бевацизумаб бағдарламалық химиотерапия кезінде, оксалиплатин, 5-фторурацил, лейковорин + бевацизумаб бағдарламалық химиотерапияға қарағанда тиімді ем нәтижелерін көрсетті. OXA/5-FU/LV/BEV жалпы бағдарламаның эффективтілігі 40,91±8,6% құрды, оның ішінен 4,54±5,1% толық регресс. OXA/CAP/BEV тобындағы жалпы терапияның эффективтілігі 45,83±8,6% құрды, оның ішінен толық регресс тек 4 науқаста байқалды, ол 16,66±5,6% құрды. Процестің үдеуінің медиана уақыты, 1-ші топта 8,3 айды құрды, 2-ші топта – 9,8 айды құрды. Амбулаторлық түрде бевацизумабты диссеминирленген тоқ ішіктің қатерлі ісіктерінде түрлі химиотерапиялық режимдарда қолдану, ем барысында қолайлы және токсикалық әсерінің басқармалылығы, осы емнің редукциялық мәлішерлікті қажет етпейді.

Түйінді сөздер: колоректальды қатерлі ісік, химиотерапия.

Summary

O.V.Zharkova¹, V.V.Karaseva², V.A.Haylenko³, E.B.Mironova³, P.S.Feoktistova⁴, K.V.Vyalova¹, S.A.Kolomiets¹

¹Kemerovo Regional Clinical Oncology Dispensary, Kemerovo

²Russian National Research MOU them. NI Pirogov, Moscow

³FGBUZ Clinical Hospital №81 Seversk,

⁴BU Yugra Khanty-Nizhnevartovsk Oncology Center

Analysis of drug therapy for disseminated colorectal cancer in outpatient clinical practice

The efficiency of two programs of chemotherapy in the treatment of 46 patients with disseminated colorectal cancer. The programme of chemotherapy of Oxaliplatin + Capecitabine, established authors, with bevacizumab showed the best results compared with Oxaliplatin + 5-fluorouracil + leukovorin with bevacizumab. The overall efficiency OXA/5-FU/LV/BEV amounted to 40,91±8,6%, 4,54 ± 5,1% of total regressions. The overall effect of therapy in the OXA/CAP/BEV amounted to 45,83±8,6%, full regression was achieved in four patients, which amounted to 16,66±5,6%. The median time to progression in the first group of patients was 8.3 months in the second – 9.8 months. Clinical application of involving bevacizumab in combination with different modes of chemotherapy in patients with disseminated colorectal cancer is acceptable and manageable toxicity that doesn't require reduction of doses.

Key words: colorectal cancer, chemotherapy.